



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

93016 / 2018 ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN Y OTRO c/ EN-M SALUD
Y DESARROLLO SOCIAL Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986

80408/2018 ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS
CIVILES c/ EN-ANMAT s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, de septiembre de 2025.

Y VISTOS: Para dictar sentencia en los presentes autos y en su acumulado 80408/18 ; y

CONSIDERANDO:

I.- Cabe señalar -ante todo- que la causa ha quedado sin sentenciar hasta la fecha por haberse traspapelado en la cantidad de expedientes digitales en trámite ante el Tribunal y que -atento lo ordenado por la Excm. Cámara previo a resolver la cautelar apelada y el interés que persiste en los intervinientes- corresponde dictar sentencia en cumplimiento del ejercicio de la Magistratura.

II.- Previo a todo análisis -atento que se trata de una acción de amparo colectiva iniciada en el expediente 93016/18 y 80408/18- es menester recordar que el artículo 43 de la CN prescribe que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más indicado, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere, o amenace, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva”.

La ley 16986 que no ha sido derogada expresamente por la reforma constitucional de 1994 y mantiene vigentes sus disposiciones bajo el amparo del texto constitucional prevé que esta acción " será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesión, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías expresas o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional con excepción de la libertad individual tutelada en el hábeas corpus" (art. 1ero).



La Corte Suprema de Justicia ha declarado que esta acción constituye un proceso excepcional sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige para su apertura circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, de modo tal que las deficiencias referidas –a que alude la ley 16986 y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción, requieren que la lesión de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional resultan de acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad.

Conforme a lo enunciado el artículo 43 de la CN debe ser interpretado de manera razonable, sin que se desprotejan los derechos esenciales ni tampoco se consagre al amparo como única vía judicial. Ello así, debido a que la garantía prevista por el constituyente no viene a suplantarse los otros procesos previstos en el código de rito, ni significa que ciertos derechos vulnerados no puedan lograr su satisfacción mediante el uso de los procedimientos ordinarios.

En este sentido, el Alto Tribunal tiene dicho que la acción de amparo es la única apta para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales o legales (Fallos: 310:877).

Máxime cuando este proceso –sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales– tiene como finalidad reparar, con la mayor premura, la lesión de un derecho reconocido en la Constitución Nacional, un Instrumento Internacional o una ley (v. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, tomo VII, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2005, pág. 137).

Esta pauta obliga al juez a ponderar la configuración de los recaudos que habilitan el empleo de esta vía. Así, los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia –lo mismo que sucede en muchas otras cuestiones de su alto ministerio– a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponde resolver de acuerdo a los procedimientos ordinarios.

Una solución contraria podría traer aparejada la desnaturalización de la vía elegida, que, por sus propias características, debe ser ágil y expeditiva para superar en el menor tiempo posible la arbitrariedad o ilegalidad en la que se la sustenta.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

En conclusión, el Poder Judicial debe ser estricto en el examen de los presupuestos que habiliten la procedencia procesal del amparo, con el propósito de que siga siendo un remedio útil para, de manera eficaz y urgente, superar aquellas situaciones arbitrarias o ilegítimas que se denuncian como manifiestas. Su generalización y aplicación a cuestiones que claramente lo exceden debe ser evitado, ya que ello incide en su transformación, y trae aparejado que pierde su real esencia y razón de ser, afectándolo seriamente, en la medida en que se permita subsumir en sus previsiones conflictos para los que no ha sido realmente previsto (Fallos: 330:1279 y 333:373).

Ello así porque la existencia de vías ordinarias para la protección del derecho que se reputa conculcado excluye la admisibilidad de la acción de amparo, sin que los jueces sean facultados para evitar las posibles democracias de dichos procedimientos por vía de autorizar otros que consideren más convenientes o expeditivos (conf. esta Cámara, Sala V in re “Labatón, Ester Ac/ Poder Judicial de la Nación”, del 25/09/96).

Así entonces la arbitrariedad o ilegalidad alegada debe presentarse sin necesidad de mayor debate y prueba. Es decir, el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal resultante de una voluntad irrazonable del sujeto demandado.

Además, y en cuanto al daño que agravia a quien demande, señalar que esta acción no procede ante la mera sospecha o probabilidad de que el perjuicio pueda llegar a producirse, sino que se exige una verdadera certeza fundada en que la lesión ya se esté produciendo o, bien, se producirá en forma inmediata (ver CNCAF; Sala IV; causa “Eventel SA” y Sala III “Unión de Usuarios c/ Telecom s/ amparo”).

Sumado a ello “en los juicios de amparo debe atenderse a la situación del momento en que se decide” (CSJN, “Centro de Estudiantes de Ingeniería La Línea Recta”, LL, 129:562; ver, asimismo, Fallos, 247:469 y 253:347), cuestión que ha permitido sostener a la doctrina que “no sentencia hay si cesó la lesión” (ver, por todos, Sagüés, Néstor; Ley Nacional de amparo, Bs. As., 1979, p. 351, con citas de Lazzarini y Bidart Campos y doctrina de CSJN; tachado de lesivo “resultaría inoficioso pronunciarse al respecto” (CSJN, Fallos, 322:2222, “Sargenti”)



III.- El objeto de esta acción de amparo colectivo iniciada por la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS CIVILES (PRODECI) en la causa 80408/18 y por la ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN contra el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION y la ANMAT (expte nro. 93016/18) -ambas acumuladas- es obtener:

.- La nulidad del punto 2do de la Resolución 946/18 (12/10/18) en cuanto autorizó sobre el medicamento MISOP200/ MISOPROSTOL la "venta bajo receta archivada" para las presentaciones 12 comprimidos sumándola a las de 4 y 8 comprimidos ya autorizadas y reservando para las presentaciones de 20, 48 y 100 la condición de venta "uso institucional y hospitalario exclusivo"

Sostienen -en lo esencial- que tal decisión es contraria a las resoluciones precedentes (3779/09, 6291/10 y 6726/18) además de aplicar el procedimiento abreviado establecido en la Resolución 855/09 que no está destinado a regular esta cuestión y no cumplido con la previa intervención del servicio jurídico, carecer de suficiente motivación y no estar viciado en su finalidad la falta de adecuación entre la medida dispuesta y la protección a la salud pública que preside el ejercicio de las atribuciones del organismo.

.- La nulidad absoluta del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo por violatoria del derecho establecido en en la Constitución Nacional y receptado en el artículo 86, incisos 1ero y 2do por violación al derecho a la vida.

El 12/05/19 este Tribunal admitió parcialmente la cautelar solicitada: a) Ordenó la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2do de la Disposición ANMAT nro 946/18 hasta tanto recaiga sentencia definitiva; y b) rechazó la suspensión del "Protocolo para la integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo".

Dicha medida fue apelada y el recurso ha sido concedido en ambos efectos no habiendo resolución a la fecha.

IV.- El Sr. Fiscal Federal - con fecha 27/12/22- narra en extenso los antecedentes del caso y las posiciones de ambas partes, acto que exime al Tribunal de formular repeticiones que atentan contra la economía procesal agregando copia del dictamen como parte integrante de esta sentencia.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

En cuanto al debate suscitado consideró lo siguiente:

"...debe considerarse que, según los propios términos de la demanda, la actora atacó conjuntamente el Protocolo y la Disposición, en el entendimiento de que el cambio en la condición de venta del producto medicinal MISOP 200 resultaba manifiestamente ilegítimo, y constituía una seria amenaza cierta y actual para la salud pública de las mujeres gestantes y de los niños por nacer. Ello al dar cabida a que el medicamento sea administrado sin la indispensable intervención de un médico diplomado, como lo exigía el art. 86 del Código Penal (en su redacción previa a la ley 27.610), y fuera del ámbito de los establecimientos hospitalarios. De igual modo, al fundamentar la admisibilidad de la vía del amparo, la actora señaló que esta acción se deduce contra dos comportamientos de una autoridad pública que, en los aspectos que motivan el cuestionamiento, en forma actual o inminente amenazan con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta al derecho a la vida y ala salud pública. Ello así, al poner en grave riesgo la vida y la salud de los niños por nacer, y la vida de las mujeres embarazadas, que quedan expuestas al uso del Misop 200"

"... la actora cuestionaba la validez constitucional de la Disposición y del Protocolo, por considerar que, deforma contraria a la ley, reintroducían el “aborto sentimental” para cualquier caso de violación, prescindiendo del requisito de la actuación penal, y que creaban una nueva causal amplia, relativa a la protección de la salud, que colisionaba con el texto del Código Penal"

"... Dichos planteos, reitero, han devenido abstractos a la luz del dictado de la ley 27.610, en atención al modelo mixto allí adoptado, y reseñado en párrafos anteriores, que combina un criterio temporal y de causales para la regulación del derecho a la a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, con los requisitos allí legislados..."

"...bajo este nuevo marco normativo, cuya constitucionalidad no ha sido impugnada por la parte actora, considero que devienen abstractos y de inoficioso tratamiento, los planteos esgrimidos en la primera parte de la demandada. En particular me refiero a los argumentos que desarrolla la asociación actora, donde señala que el Protocolo y la Disposición implicaron acoger una interpretación y modificación contra legem del viejo texto del artículo 86 del CP, incorporando indicaciones o causales no previstas, y la creación pretoriana por parte de la CSJN de un derecho a abortar no



legislado por el Congreso. Todo ello, sobre la base de lo resuelto por la CSJN en la citada causa F.A.L., y la exhortación que incluye la última parte de su fallo, cuya validez cuestiona";

.- "... los planteos dirigidos contra la Disposición de ANMAT no se encuentran desvinculados de aquellos que fueron ensayados contra el Protocolo, sino que la propia actora les dispensó un cuestionamiento y fundamentación conjunta, en el entendimiento de que ambas normas se complementaban para generar una modificación ilegal del Código Penal que ponía en riesgo los derechos invocados. Por este motivo, entiendo que los argumentos vertidos en torno a la existencia de vicios sobre los elementos esenciales de la Disposición (referencia la nro 946/18), con fundamento en la LNPA, tienen un carácter subsidiario. Además, carecen de una entidad y autonomía suficiente que permita su tratamiento de forma separada del agravio principal. A la vez, no se demuestra suficientemente la relación directa y esencial de esos planteos con el bien jurídico reclamado, ni con el fundamento de la legitimación invocada. Así no se verifica en ese punto el nexo lógico entre el estatus afirmado por el litigante y el reclamo que se procura satisfacer (cfr. Fallos 326:1007; 328:2429; 331:2287; 342:1549)" (el resaltado es propio)

.- "los planteos dirigidos a sostener la nulidad de la Disposición con sustento en alegados vicios legales de objeto, causa, motivación, procedimiento y finalidad (que según la actora, son los que conservan lozanía luego de la entrada en vigor de la ley 27610) no exhiben una relación directa e inmediata con el derecho cuya defensa invoca la actora. A ello debe añadirse que, tal como lo vengo sosteniendo, la discusión en torno a la legitimidad de la autorización ordenada en la Disposición de ANMAT resulta ociosa bajo el marco normativo actual, dado por la ley 27610 y el Protocolo actualizado la luz de esta última. Por cierto, estas normas reconocen a las gestantes el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y la obligación de los efectores públicos y privados de salud y sus autoridades de garantizar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda, lo que comprende las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo (cfr. Art. 12 ley 27610)";

.- " la ANMAT ha resuelto aprobar la forma de expendio cuestionada inicialmente por la actora, en ejercicio de la competencia específica atribuida por el decreto 1490/92, sus modificatorias y complementarias. Asimismo, la decisión se encuentra dentro del ámbito de la denominada discrecionalidad técnica del





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

órgano en la medida en que su tarea es específica como unidad organizativa en el ámbito de la Secretaría de Salud donde actúa (...) Así el objeto de la Disposición es propia de la autoridad de aplicación y reservado -en principio- a la valoración que hace al ejercicio de su competencia natural. De modo que solo puede ser objeto de intervención judicial cuando dicha actividad exhibiera ilegitimidad o arbitrariedad manifiestas. Estos supuestos no aparecen configurados en el caso de autos, habida cuenta de que, como se apuntó anteriormente, los cambios normativos reseñados han tornado abstractos los cuestionamientos constitucionales vertidos en la demanda"

"... Por las razones explicadas, consideró que los planteos esgrimidos en la demanda se han tornado de inoficioso tratamiento, bajo el contexto jurídico actual dado por la entrada en vigor de la ley 27.610, el Protocolo actualizado en 2021- de conformidad con dicha ley- y sus normas complementarias. Previsiones que, no sobra recordar, no han sido expresamente cuestionadas en su constitucionalidad por la actora..."

V.- Es necesario recordar -previo a analizar la cuestión sometida a esta jurisdicción- que conforme reiterada y uniforme jurisprudencia del Alto Tribunal, el juez no está obligado a seguir y dar tratamiento a todas y cada una de las argumentaciones que se le presentan, ni a examinar la totalidad de las probanzas aportadas a la causa, sino a abordar aquellas cuestiones y analizar los elementos arrimados que resulten relevantes y conducentes para dirimir el conflicto que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (ver doctr. , de fallos 258:304; 262:222; 265:301 entre muchos)

Es oportuno precisar -en igual sentido- que la autoridad jurisdiccional al dictar sentencia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 inciso 6to, "...podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubieran sido invocados oportunamente como hechos nuevos..." (ver artículo 163 inciso 6to) ; y -asimismo- si bien "... la sanción y vigencia de un nuevo texto normativo no configura una nueva situación fáctica, en los términos del artículo 365 del CPCCN, ello no obsta a la valoración que corresponde hacer de cualquier norma legal o reglamentaria aplicable al caso, al momento de resolver la cuestión de fondo (ver en igual sentido causa 58418/18 "New textil" resolución del 11/04/2019; 15616/21 del 09/10/23)



VI.- Previo a todo es necesario resaltar -vista la índole la cuestión en debate- que "el individuo es el eje y centro de todo el sistema jurídico y que, en tanto fin en sí mismo, la inviolabilidad de la persona constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos:316:479, votos concurrentes). A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75,inc. 22, de la Ley Suprema), ha reafirmado en diversos pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 323:3229in re "Campodónico de Beviacqua"; 321:1684; 323:1339, mayoría y votos concurrentes y dictamen del señor Procurador General de la Nación a cuyos fundamentos se remiten), agregando que no cabe imponer a la persona con discapacidad una mayor mortificación que la que su propio estado le ocasiona (CCF 12922/2006/CA2-CS1“S., J. L. c/ COMISION NAC ASESORA PARA LA INT DE PERSONAS DISCAPAC y otro s/ amparo”, sentencia del 5 de diciembre de 2017, voto del juez Rosatti) -ver CSJN; Fallo 21/10/21; causa B.C.B.; voto Dr. Rossatti.

" El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo este último el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional; ello así por ser el eje y centro de todo el sistema jurídico, siendo su vida un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (confr. arg. de Fallos: 302:1284; 310:112;316 :479; 323:3229; 329:4918 y 338:1110). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que la tutela de este derecho es una manda consagrada por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales que tienen tal jerarquía, lo que implica la obligación impostergable del Estado Nacional para garantizarlo con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos:321:1684; 323:1339; 323:3229; 329:1638; y artículo 75, inciso22, de la Ley Suprema; artículo 12, inciso c, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inciso 1 de los artículos 4° y 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—; inciso 1°, del artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como así también el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 25





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

de la Declaración Universal de Derechos Humanos; “Farmacity”, Fallos:344:1557, voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti) ver voto dr. Lorenzetti; CSJN; fallo "Garay" del 02/07/24"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emplaza que "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" y así también " El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) dispone que sus Estados parte “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” (Art. 12) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador (PSS) estatuyo que "Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social" (Art. 10), entre muchas normas nacionales y supranacionales que declaran esta garantía consagrada en nuestra Constitución Nacional (ver artículos 31 y 33)

Ha señalado -además- el organismo que "la asistencia sanitaria esencial estará basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables . El/la paciente tiene derecho a una atención médica de calidad y continua" y "el derecho a la salud, su derecho derivado, a la asistencia sanitaria y el valor, principio y derecho dignidad, fundamentan el derecho a la asistencia sanitaria de calidad, al tiempo que se protege la integridad y la inviolabilidad del cuerpo y la salud de los/as pacientes. El Equipo de Salud, ya sea en la práctica médica o en la investigación en salud, debe bregar por reducir al mínimo la afectación a la integridad y la inviolabilidad del cuerpo y la salud de el/la paciente".

VII.- A la fecha se encuentra vigente la ley 27610 que autoriza y regula la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la interrupción legal del embarazo (ILE) y constituye un cambio normativo relevante para la controversia planteada (*"...la sanción de una nueva norma no es un hecho, solo implica un cambio legislativo que no necesita ser invocado por las partes ya que el magistrado conoce el derecho - ver Peyrano, Jorge; "Aspectos procesales de la ley desinexatoria"; LL 1994-B ,pag. 918).*

La ley 27610 (BO 15/01/21) "regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ya la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos



humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar ya fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible" (artículo 1ero)

Enumera los Derechos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar: a) Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley; b) Requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley; c) Requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley; d) Prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral ya métodos anticonceptivos eficaces (artículo 2do).

Establece que sus disposiciones se enmarcan en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en virtud de la protección que otorgan a los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, a la vida, a la autonomía, a la salud, a la educación, a la integridad, a la diversidad corporal, a la identidad de género, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencias y pensamientos, a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, a la igualdad real de oportunidades, a la no discriminación ya una vida libre de violencias (artículo 3ro).

Respecto a la " **Interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE)** " señala que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional; y que - fuera del plazo





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

dispuesto en el párrafo anterior - la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida; b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante (artículo 4to).

Establece derecho de la persona gestante a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se establecen en la presente ley en las leyes 26.485, 26.529 y concordantes (art. 5to); y que el personal de salud debe garantizar las siguientes condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y postaborto: a) Trato digno: El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar; b) Privacidad: Toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener y transmitir información y documentación clínica del paciente debe garantizar la construcción y preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y las personas que solicitan la atención, y observar el estricto respeto por su intimidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad; solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su autorización expresa, conforme a las disposiciones del artículo 8º de la presente ley. Asimismo, deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros. En los casos de violación cuyas víctimas sean niñas o adolescentes, el deber de comunicar la vulneración de derechos prevista en el artículo 30 de la ley 26.061 y el deber de formular denuncia penal establecido en el artículo 24, inciso e), de la ley 26.485 en el marco de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Penal, deberán cumplir confidencialmente respetando el derecho a la privacidad yidad de niñas y adolescentes, su capacidad progresiva e interés superior de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 y el artículo 26 del Código Civil y Comercial, y no deberán obstruir ni dilatar el acceso a los derechos establecidos en la presente ley; c) Confidencialidad. El personal de salud debe crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención de atención y también con posterioridad. Debe informar durante la consulta que la confidencialidad está garantizada y alcanza resultada por el secreto médico. El paciente tiene derecho a que toda persona que



participe en la elaboración o manejo de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, deberá respetar el derecho a la confidencialidad, salvo expresa autorización escrita de la propia paciente; d) Autonomía de la voluntad. El personal de salud debe respetar las decisiones de los pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones del paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad; e) Acceso a la información. El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de los pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. El paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada. Se debe proporcionar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica. Dicha información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles. El personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar la información disponible sobre los derechos protegidos por la presente ley de forma dinámica ya lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita; f) Calidad. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme a los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. La será atención brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada (ver artículo 5to).

Impone la obligación de que "realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con el artículo 4º, el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ley 25.673, lo siguiente: a) Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los tratamientos posteriores necesarios, siguiendo los criterios del artículo anterior; b) Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso; c) Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en la ley 25.673 o la normativa que en el futuro *la* reemplace

En cuanto al "Consentimiento informado la ley dispone que se - requiere *previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo* - el





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529 y concordantes y en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho (art- 7mo)

Respecto a la solicitud indica que -en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 26.061, el artículo 7º del anexo I del decreto 415/06, el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación y la resolución 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación- la solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo deberá ser efectuada de la siguiente manera: a) Las personas mayores de dieciséis (16) años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley; b) En los casos de personas menores de dieciséis (16) años de edad, se requerirá su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial y la resolución 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061, el artículo 7º del anexo I del decreto reglamentario 415/06 y el decreto reglamentario. 1.282/03 de la ley 25.673 (ver artículo 8); y respecto a las "Personas con capacidad restringida" Si se trata de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo deseara, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y, por tanto, es necesario que el diseño del sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que no existan abusos y las decisiones sean tomadas por el titular del derecho. Si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en la presente ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, a falta o ausencia de este o esta, la de una persona allegada, en los términos del artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 9).

Asimismo establece que "...el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá: a) Mantener su decisión en todos los ámbitos, público, privado o de la seguridad social, en los que



ejerza su profesión; b) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otro profesional en forma temporánea y adecuada, sin dilataciones; c) Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable . conciencia")

En relación a las "Obligaciones de los establecimientos de salud" la norma prescribe que "aquellos efectos de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio de derecho de objeción de conciencia de conformidad con el artículo anterior, deberá prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de características similares al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos se debe garantizar la calidad de la práctica conforme a las provisiones de la presente ley Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica (artículo 11).

Garantiza la cobertura y calidad de las prestaciones. El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en la ley 23.660 y en la ley 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por la ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidos en la ley 26.682, de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brindan atención dentro de la reglamentación del decreto 1.993/11, las obras sociales de las fuerzas armadas y de seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la ley 24.741, de obras sociales universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brindan servicios médico-asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo (artículo 12).

Implementa la "Educación sexual integral y salud sexual y reproductiva" El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la ley 26.150, de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las leyes 23.798, 25.673, 26.061, 26.075, 26.130, 26.150, 26.206, 26.485, 26.743 y 27.499, además de las leyes ya citadas en la presente ley. Deberán, además, capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes ya los y las profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud, a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuado a quienes solicitan realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley, así como a los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que actúen en dichos procesos (ver art. 13).

Establece la pena conforme al nuevo artículo 85 del Código Penal de la Nación que sustituye al vigente hasta la entrada de la ley y que dice lo siguiente: *El o la que causare un aborto será reprimido: 1. Con prisión de tres (3) a diez (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2. Con prisión de tres (3) meses a un (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana catorce (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 (art. 14)*

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis del Código Penal de la Nación, el siguiente: *" Será reprimido o reprimido con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados (art. 15)*

Sustituye el anterior artículo 86 del C. Penal por el siguiente: *" No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante: 1. Si el embarazo fuere producto de una violación. En este caso, se debe garantizar la práctica con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el o la profesional o personal de salud interviniente En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida y 2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud **integral** de la persona gestante (artículo 16).*



Sustituye el artículo 87 del Código Penal por el siguiente: *Será reprimido o reprimida con prisión de seis (6) meses a tres (3) años, el o la que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona gestante fuere notorio o le constare* (art 17).

Y también el artículo 88 del C.Penal por el siguiente: *Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año, la persona gestante que, luego de la semana catorce (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible* (art. 18)

Regula la capacitación del personal de salud en los contenidos de esta ley y de la normativa complementaria y reglamentaria. A tal fin, el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementarán los correspondientes programas de capacitación (art.19).

Prevé que la autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el Poder Ejecutivo nacional (art. 20) y que esta norma es orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina (art. 21).

VIII.- La señalada ley es una norma de "orden público" ("...el legislador, al disponer que es de orden público, ha definido a la ley como contenedora de un conjunto de principios de orden superior estrechamente vinculados a la existencia y conservación de la organización social establecida y limitadora de la autonomía de la voluntad" (ver CSJN. "Rodriguez, Ines" del 21/10/22)

El decreto 516/21 y el Protocolo 1535/21 actualizado por resolución 1063/23 reglamentan lo allí enunciado.

El PROTOCOLO dispone: " en función de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 27.610, corresponde incorporar el presente Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del (Actualización 2022) al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, creado por Resolución N° 432 de fecha 27 de noviembre de 1992 de la entonces SECRETARÍA DE SALUD del ex MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

El Protocolo 1535/21 (actualizado por Resolución 1063/21) distingue entre la INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE) de la INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE) y establece para ambos casos la **EVALUACIÓN MÉDICA** en ambos casos (IVE e ILE) a los efectos de valorar, en conjunto con la gestante, cuál es el método más apropiado para realizarla.

El procedimiento a utilizar dependerá de la edad gestacional, las preferencias de la mujer o persona con otra identidad de género y las posibilidades del centro asistencial. Para determinar la edad gestacional, en general, es considerar adecuada la fecha de la última menstruación (FUM), el examen pélvico bimanual, abdominal y el reconocimiento de los signos del embarazo. También pueden utilizarse la determinación de la subunidad de la Gonadotropina Coriónica Humana (sub β HCG) o una ecografía (OMS, 2014).

"El objetivo de la anamnesis es poder estimar la edad gestacional, ya su vez, identificar las posibles contraindicaciones para los distintos procedimientos y aquellos factores que puedan suponer un mayor riesgo de complicaciones"

Indica -Respecto al "PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO"- que las opciones terapéuticas para realizar una IVE/ILE dependen de la edad gestacional, las preferencias de la persona gestante y las posibilidades del centro asistencial y prescribe que:

" Es esencial realizar una adecuada consejería previa en la cual se expliquen las diferentes posibilidades, de manera que la persona pueda tomar su decisión basada en una información completa."; " Por tratarse, en general, de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres y personas con otras identidades de género que requieren una IVE/ILE puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria";" Sin embargo, es necesario que se pueda brindar atención integral para IVE/ILE en todos los niveles del sistema de salud para atender a personas que presenten eventuales complicaciones, se encuentren en etapas más avanzadas del embarazo o cuando haya un compromiso de salud y sea conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica"

Asimismo el Protocolo prevé que " *Independientemente de la edad gestacional, se indicará la internación para realizar el procedimiento medicamentoso en aquellas personas que presenten comorbilidades como enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, neuropatías, diabetes mellitus o hipertensión arterial descompensada y tratamiento actual con anticoagulantes entre otras. Deben*



considerarse también situaciones de vulnerabilidad social como falta de red social, violencia, distancia geográfica y otras. La internación deberá ser bajo seguimiento continuo a partir del momento en que se inicie el tratamiento con misoprostol" -criterio similar en ambos Protocolos (1535/21 y 1063/22 ver punto 8.4 "aborto con medicamentos".

Conforme a todo lo señalado surge evidente que -a results de la entrada en vigencia de la ley 27610 y sus normas reglamentarias tornan abstracto el planteo de nulidad respecto al vigente al inicio de la acción pues éste ha sido reemplazado por hoy vigente ajustado a las previsiones legales de la ley 27610.

En tal sentido -es oportuno señalar- que "no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (ver CSJN, Fallos 304:759; 312:2348; 320:2851; 324:333; 326:1007; 332:5 etc), de forma que les este vedado dictan pronunciamientos inoficiosos por referirse a planteos que se han tornado abstractos al no decidir un conflicto actual (fallos 315:2093; 320:2603; 329:1898, entre otros), en tanto la desaparición de ese presupuesto procesal -caso o controversia- implica la del poder de juzgar (ver fallos 315:123; 340:1084; 341:1356 entre muchos otros).

Conforme a lo señalado corresponde compartir las conclusiones enunciadas por el Sr. Fiscal Federal y declarar abstracto el planteo de nulidad referido al mencionado Protocolo.

IX.- Resta por examinar la nulidad peticionada respecto al artículo 2do de la Resolución 946/18 de la ANMAT, que establece la nueva condición de venta: venta bajo receta archivada para las presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos vaginales (artículo 2do), además de autorizar una nueva presentación de MISOP 200 en envases de 12 comprimidos (ver artículo 1ero).

Los cuestionamientos de ambas codemandantes (anteriormente enunciados en la resolución cautelar de fecha 05/12/19) están dirigidos al 2do artículo y fundados en "... a) graves vicios en su causa en tanto la modificación dispuesta por la ANMAT sobre las condiciones de expendio del MISOP 200 contradice los graves riesgos que entraña su aplicación fuera del ámbito hospitalario y las normas aplicables en la materia; b) graves vicios en su objeto atento se aparta de numerosos precedentes (disposiciones 3779/09, 6291/10 y 6726/18) sin motivar el cambio de fundamento c) vicios en el procedimiento por cuanto se atiene al procedimiento abreviado establecido





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

en la Disposición 855/09 destinado a ser aplicado en un supuesto distinto al cambio de condiciones de venta de productos medicinal y omitió –además- dar intervención al órgano de asesoramiento jurídico del organismo; d) déficit ostensible en la motivación del acto; e) vicio en la finalidad por cuanto existe una notoria falta de adecuación de la medida dispuesta en relación a la protección de la salud pública que preside el ejercicio de las atribuciones del organismo.

X.- La política nacional en materia de salud pública está conformada por normas de antigua vigencia como son, entre otras, la ley 16.463 de “Medicamentos” (1964), la ley 17.132 del “Arte de curar” (1967), la ley 17.565 de “Farmacias” (1967), la ley 17.818 de “Estupefacientes” (1968), la ley 19.303 de “Drogas” (1971), el decreto 1490/1992 que crea la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y regula su competencia.

Esas normas, dada la trascendencia del ámbito que están destinadas a regular, han habilitado históricamente una amplia e intensa intervención por parte del Estado Nacional. Así, desde 1964, la ley 16.463 estableció que la elaboración y depósito de cualquier medicamento o producto de uso y aplicación en la medicina humana requerirán autorización y serán controlados por la autoridad sanitaria (artículos 1º; 2º; 9º)

La ley 17.132 sobre el ejercicio de la medicina prohibió a toda persona que no esté comprendida en esa ley prescribir o indicar tratamientos médicos (artículos 2º y 4º) y obligó a los profesionales de la salud a “ajustarse a lo establecido en las disposiciones legales vigentes para prescribir alcaloides” (artículo 19) y - a través de las leyes de “Farmacias” 17.565, de “Estupefacientes” 17.818 y de “Drogas” 19.303 también se reguló minuciosamente el expendio de drogas y medicamentos (artículo 9º de la ley 17.565, artículos 4º y 16 de la ley 17.818 y capítulos IV y V de la ley 19.303).

"El objetivo de todas estas normas –como lo ha expresado esta Corte con referencia a la ley 16.463– es evitar el uso indebido de medicamentos, así como determinar la peligrosidad de estos, su comprobada y comprobable acción y finalidades terapéuticas y sus ventajas científicas, técnicas o económicas, de acuerdo con los adelantos científicos (Fallos:310:112, considerando 6º) -ver CSJN fallo "Asociación Civil Macame" : 05/07/22).



En cuanto a los "pacientes" la ley 26.529 de derechos de los pacientes prescribe como un derecho esencial que los pacientes tienen derecho a la asistencia médica (art. 2º, inc. a)], por parte de los/as profesionales de la salud (y de las instituciones sanitarias). Se trata de un deber ético y una obligación jurídica en cabeza del/la profesional de la salud (art. 19, inc. 2º, ley 17.132).

La ley 16463 prevé que *"los medicamentos que se expendan al público en su envase original, deberán reunir las condiciones técnicas de identificación u otras que establezca la reglamentación. Esta determinará, así mismo, teniendo en cuenta la naturaleza o peligrosidad del uso indebido de los medicamentos, la condición de su expendio, que podrá ser: libre, bajo receta, bajo receta archivada y bajo receta y decreto."* (ver artículo 5to) ; y que "El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública clasificará los productos comprendidos en el artículo 5to, según la naturaleza, composición, actividad, acción farmacológica y procedimientos farmacotécnicos de preparación estableciendo condiciones para su autorización, acordes con los adelantos científicos reconocidos, los intereses de la salud pública y la defensa económica del consumidor" (artículo 9).

El **decreto 9763/ 64 -reglamentario de la ley 16463"Medicamentos"** - establece "...en las autorizaciones de elaboración y venta de las especialidades medicinales y de los medicamentos industriales y en los certificados que en su consecuencia se extiendan, se dejará constancia de las condiciones en las cuales deberán ser despachadas en las farmacias. Estas condiciones serán: a) venta bajo receta y decreto; b) **venta bajo receta archivada**; c) venta bajo receta; d) venta libre. Así "corresponde a la condición de "venta bajo receta archivada" a todas aquellas especialidades medicinales y medicamentos industriales constituidos por principios activos que por su acción solo deben ser utilizados bajo rigurosa prescripción y vigilancia médica, por la peligrosidad y efectos nocivos que un uso incontrolado pueda generar (ver artículo 35 citado decreto) ; y prohíbe cualquier actividad o tenencia de drogas y productos médicos fuera de aquellos habilitados por la autoridad sanitaria y reguló con detalle bajo qué tipo de recetas y control sanitario pueden despacharse las distintas drogas (artículos 4ºy 35).

Mediante el **decreto 1490/92** (modificado por su similar 1886/2014) se declaró de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de la salud de la población que se desarrollen a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad de los productos, sustancias, elementos y





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

materiales que se consumen o utilizan en la medicina (artículo 1º) y se creó, en el ámbito de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social, la ANMAT (ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA) estableciendo su competencia (ver artículos 2º y 3º) en lo referido a:

A) el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana (el resaltado es propio).

B) el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de los alimentos acondicionados, incluyendo los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana, como también de los productos de uso doméstico y de los materiales en contacto con los alimentos;

C) el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de los productos de higiene, tocador y cosmética humana y de las drogas y materias primas que los componen;

D) la vigilancia sobre la eficacia y la detección de los efectos adversos que resulten del consumo y utilización de los productos, elementos y materiales comprendidos en los incisos a), b) y c) del presente artículo, como también la referida a la presencia en los mismos de todo tipo de sustancia o residuos, orgánicos e inorgánicos, que puedan afectar la salud de la población ;

E) el control de las actividades, procesos y tecnologías que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos, sustancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética humanas;

F) la realización de acciones de prevención y protección de la salud de la población, que se encuadren en las materias sometidas a su competencia

G) toda otra acción que contribuya al logro de los objetivos establecidos en el artículo 1º del presente decreto.

"La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT) será el órgano de aplicación de las normas legales que rigen las materias sujetas a su



competencia, las que en el futuro se sancionen y las que en uso de sus atribuciones dicten el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL y la SECRETARIA DE SALUD " (ver articulo 4to del decreto 1490/92)

XI.- El pedido de nulidad de la Disposición 946/18 conduce a señalar *-conforme lo expresara la Sala V de la Cámara del Fuero al resolver la causa nro. 80/20, con fecha 17/06/25-* que “la validez del acto administrativo depende del cumplimiento de ciertos requisitos esenciales que se concretan en los ‘elementos’ de dicho acto, los cuales deben concurrir simultáneamente en la forma requerida por el ordenamiento jurídico. Estando reunidos dichos ‘elementos’ en la forma expresada, el acto administrativo es ‘perfecto’: válido y eficaz. De modo que los ‘elementos’ del acto administrativo son los requisitos que debe concurrir simultáneamente para la plena validez y eficacia del acto en cuestión” (Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, Buenos Aires, Abeledo- Perrot, 1993, pág. 277). Asimismo, se ha dicho que “son elementos esenciales del acto administrativo los requisitos que deben concurrir, sin vicios, para que el acto sea plenamente válido” (Comadira, Julio R., “Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Abeledo- Perrot, 1996, pág. 36),

Asimismo "en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 7º de la Ley Nº 19.549 enumera los requisitos esenciales del acto administrativo, entre los que se encuentra la motivación, elemento que interesa en el sub lite atento a los términos del recurso interpuesto. Allí se establece que el acto administrativo deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitirlo, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del artículo mencionado, esto es, los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y el derecho aplicable. Cabe señalar que la doctrina ha definido la motivación como la exposición de los motivos que indujeron a la Administración Pública a la emisión del acto y ha entendido que este elemento contribuye a que se establezca si el acto que se emite está de acuerdo con los respectivos antecedentes de hecho y de derecho que constituyen su causa jurídica o motivo, aclara o facilita las cuestiones atinentes a la interpretación del acto y permite el mejor control jurisdiccional sobre la exactitud de los motivos en cuyo mérito se dictó el acto (Marienhoff, cit., págs. 327 y ss.).

No puede soslayarse -atento la competencia asignada a la ANMAT - que " la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el control judicial de los actos administrativos de la naturaleza que se está analizando en la especie debe





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

ejercerse dentro de los límites de la razonabilidad, sin sustituir la discrecionalidad técnica del órgano competente. En efecto, si bien el Poder Judicial posee la facultad de revisar los actos emanados de la Administración, dicho control se circunscribe —salvo arbitrariedad manifiesta— a la verificación de su legitimidad, sin extenderse a la evaluación de su oportunidad o conveniencia, aspectos que corresponden a los funcionarios competentes en ejercicio de las facultades de que se hallan investidos por las normas cuya validez no ha sido objetada (v. dctr. aplicable mutatis mutandis al presente en Fallos: 304:1335; 314:1251, entre otros)" (..) "No obstante el control judicial sí puede verificar si el acto administrativo cumple con los requisitos de validez exigidos por la normativa aplicable. En el presente caso, no se advierten vicios en la decisión administrativa. (Del voto en disidencia del Dr. Gallegos Fedriani; causa 18686/24; resol. 15/04/25).

Además cabe resaltar que los actos emanados del ejercicio de funciones administrativas gozan de presunción de legitimidad y el principio de legitimidad, inherente a todo acto administrativo impone sobre quien alega su nulidad la carga de alegar y demostrar lo contrario (cf. Fallos: 310:234). En consecuencia, carece de fundamentación sostener su carácter ilícito o arbitrario sin la existencia de un análisis concreto, minucioso y detallado en relación con los elementos y pruebas que despojarían a dichos actos de su validez jurídica (cf. Fallos: 318:2431; 321:685; 331:466)

XII.- Cabe memorizar los antecedentes de la citada Disposición 946/18 y ello conduce a la **Disposición 3646/98**- mediante la cual la ANMAT dispuso la "**venta bajo receta archivada**" de todas las especiales medicinal que contienen Misoprostol ya sea como monodroga o asociada a Diclofenac (*ver Artículo 1º— Unifícase la condición de expendio de las especialidades medicinales que contienen Misoprostol como monodroga o asociada a Diclofenac, las que deberán comercializarse bajo la condición de VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA*)

En 2018 por Disposición nro. 6726/18- la ANMAT autorizó la nueva presentación **MISOP 200 (misoprostol)** en presentaciones de 4, 8, 20, 48 y 100 comprimidos en la condición "**venta bajo receta archivada- uso institucional y hospitalario exclusivo**" (cabe señalar que el "Laboratorio Dominguez SA" ya comercializaba el producto "MISOP 25")



Seguidamente -a solicitud también del "Laboratorio Dominguez SA"- la ANMAT dictó la Disposición 946/18 (12/10/18) y resolvió: a) autorizar la nueva presentación del MISOP 200 en envases de 12 comprimidos; y **b) permitir para las presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos la "venta bajo receta archivada" modificando la Disposición 6726/18 en relación a las presentaciones ya existentes y a ésta nueva** (esta decisión conforma el agravio de las actoras)

Previo a ello -con fecha 27/09/18- la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos dictaminó favorablemente a la admisión de la nueva presentación solicitada.

XIII. El examen de la Disposición 946/18 y el marco jurídico que la contextualiza conduce *-dentro del marco de conocimiento que permite un juicio sumario como el amparo que requiere la conformación de la "manifiesta" ilegitimidad-* a desestimar la nulidad intentada porque no aparece demostrado que dicho acto administrativo esté viciado -en conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 19549- en sus elementos (art. 7mo ley 19.549).

Esto así por cuanto la Disposición 946/18:

.- Está dictada por ANMAT en ejercicio de su competencia (inciso a) artículo 7mo ley 19549)

.- Está ajustada a la Disposición 3646/98 que establece la "venta por receta archivada" de todo medicamento que contenga MISOPROSTOL

.- La modificación a lo dispuesto en la Disposición 6726/18- no aparece "manifiestamente" ilegítimo (visto el requisito en la acción de amparo). Ello así vista la vigencia de la Disposición 3646/98 que enmarca a las decisiones que se adopten en relación a todo medicamento que contenga la droga "misoprostol" (la cual no ha sido contrariada) y que abarca a ambas disposiciones (6726/18 y 946/18).

.- La ANMAT ha cumplido -en su artículo 1ero- con el trámite establecido en la Disposición 855/89 para autorizar una nueva presentación (misop 200 por 12 comprimidos) conforme surge de su artículo 1ero ("*..., la **Disposición 855/89** -norma regulatoria para la "Presentación que deberá efectuarse para solicitar la aprobación de una nueva presentación de venta en cuanto al contenido en unidades, mililitros, gramos etc" establece en su artículo 1ero lo siguiente: "...para solicitar la aprobación de una nueva presentación de venta en cuanto a su contenido en unidades,*





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 11

mililitros, gramos etc., se deberá presentar con carácter de declaración jurada la solicitud...." : y la disposición contenida en el artículo 2do se funda en las Disposición 3646/98 que autoriza la "venta bajo receta archivada" de la droga misoprostol.

Es relevante señalar -además- que no se observa en tal decisión un apartamiento por parte del organismo de la finalidad de su actuación -tal es la protección de la salud pública- en el marco de su competencia.

Esta conclusión aparece constatada -además- al leer las características que presenta la "**venta bajo receta archivada**" que exige que los medicamentos así comercializados " **solo deben ser utilizados bajo rigurosa prescripción y vigilancia médica, por la peligrosidad y efectos nocivos que un uso incontrolado pueda generar " por lo cual la salud de todos quienes reciben esta medicación se encuentra protegida vista la responsabilidad que le corresponde al médico que prescribe este medicamento atento como se indica su prescripción (ver artículo 35 ; decreto 9763/64 -reglamentario ley de medicamentos).**

Sumado a ello tampoco puede ignorarse- que la autoridad competente (ANMAT) ha dispuesto un estricto control sobre los medicamentos que contienen MISOPROSTOL: a) está sometido a un "Plan de gestión de riesgo- Resol. 5358/12- (ya que se encuentra dentro del listado de sustancias vigiladas (de riesgo) y que consiste en un conjunto de actividades e intervenciones en farmacovigilancia diseñada para identificar, caracterizar, prevenir o minimizar riesgos relacionados con productos medicinales, este Plan de Gestión de Riesgo siempre debe ser aprobado previo al registro y modificado en caso de que se evidencie alguna alerta tanto a nivel local como internacional; y b) está incluido en el "Sistema Nacional de trazabilidad de medicamentos" alcanzado por Resolución 435/11 y por Disposición ANMAT 963/15 y 10564/16 que exige que "las personas físicas o jurídicas que intervengan en la cadena de comercialización, distribución y dispensación de especialidades medicinales, incluidas en el Registro de Especialidades medicinales, deberán implementar una sistema de trazabilidad que permita asegurar el control y seguimiento con el fin de poder fiscalizar todos los pasos de un medicamento desde su producción , distribución, comercialización y expendio al paciente debiendo estar informados los datos de nombre y apellido, y DNI del mencionado".

Conforme a lo dicho no surge -en el marco de este amparo- acreditada la ilegitimidad de la Disposición 946/18 por lo cual corresponde rechazar la petición de nulidad.



En consecuencia y por todo lo dicho, FALLO:

1º) Rechazando la acción de amparo deducida por las demandantes en las causas 93016/18 y 80408/18 conforme los términos enunciados en los considerandos IX y XIII.

2º) Agréguese una copia de esta sentencia en la causa nro. 80408/18 cúmplase con la notificación a los litigantes en dicha causa.

3º) Imponiendo las costas por su orden atento la complejidad de la cuestión debatida y la forma en que se resuelve (art. 68 segunda parte del CPCCN).

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal y publíquese en el Registro de Procesos Colectivos. Oportunamente archívese.

MARTIN CORMICK

JUEZ FEDERAL